📋

v2 Proposta Preliminar – Projeto Emagrecendo Cajamar (revisada 09/04/26)

Plano Piloto 2026 — Versão Revisada | 09/04/2026

> Esta versão incorpora os ajustes técnicos resultantes da revisão realizada em 09/04/2026, com base na Ata de Reunião de 26/03/2026 e nas versões anteriores do projeto.

---

1. Apresentação

O Projeto **Emagrecendo Cajamar** é uma iniciativa intersetorial em fase preliminar de estruturação, construída a partir de alinhamento entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (DDEE), com apoio futuro de outras áreas estratégicas da Administração Municipal.

O projeto nasce como **plano piloto** voltado ao enfrentamento da obesidade no município, combinando cuidado em saúde, acompanhamento multiprofissional, educação em saúde, estratégias de adesão e articulação de apoio externo para estrutura complementar e engajamento.

A proposta parte de uma compreensão central: a obesidade deve ser tratada como tema de saúde pública, com impactos sobre qualidade de vida, saúde mental, comorbidades, vínculo com a atenção primária e bem-estar social. O piloto foi concebido para testar um modelo estruturado, mensurável e potencialmente institucionalizável — e não como ação pontual ou campanha isolada.

---

2. Contexto e Justificativa

2.1. Contexto de saúde pública

A reunião técnica registrou como base inicial do piloto o universo de **6.928 adultos diagnosticados com obesidade graus 1, 2 e 3**, dos quais **978 se encontram em obesidade grau 3**. A proposta inicial considera trabalhar com uma **amostra aproximada de 350 pessoas**, sem restringir o projeto apenas a adultos, prevendo participação de gestantes, idosos, adolescentes e crianças, além do público adulto geral.

Esse cenário indica uma oportunidade concreta para organização de um cuidado mais estruturado, com foco em pessoas que demandam acompanhamento contínuo e estímulo adicional de adesão.

2.2. Oportunidade institucional

O Projeto Emagrecendo Cajamar permite ao município:

- testar um modelo organizado de cuidado e adesão;
- fortalecer indicadores acompanhados pela Atenção Primária;
- integrar diferentes profissionais e ações já existentes;
- estruturar uma política pública com potencial de continuidade;
- mobilizar apoio institucional e parcerias externas de forma complementar.

2.3. Inserção em estratégia mais ampla

Durante a reunião técnica, a Secretaria de Saúde informou que está finalizando a **linha de cuidado para pessoas com sobrepeso e obesidade do município**, da qual o Emagrecendo Cajamar deverá fazer parte, ao lado de outros programas congêneres. Isso reforça o caráter estratégico do piloto como etapa inicial de uma ação mais ampla, perene e institucionalmente ancorada.

---

3. Objetivo Geral

Implantar um plano piloto municipal de acompanhamento ao emagrecimento saudável, com abordagem multiprofissional, monitoramento contínuo, educação em saúde e estratégias de adesão, de modo a gerar resultados assistenciais, sociais e institucionais, com potencial de institucionalização futura como política pública municipal permanente.

---

4. Objetivos Específicos

- apoiar o cuidado de pessoas com obesidade a partir de um fluxo estruturado de acompanhamento;
- ampliar a adesão, permanência e vínculo dos participantes com o programa;
- fortalecer indicadores institucionais relacionados à atenção primária e às ações multiprofissionais;
- integrar educação em saúde, suporte clínico e estímulos de engajamento;
- estruturar uma frente complementar de apoio externo para academia funcional, incentivos e monitoramento;
- gerar um piloto replicável, mensurável e institucionalmente defensável.

---

5. Público-Alvo

5.1. Amostra inicial

A proposta inicial considera uma **amostra de aproximadamente 350 participantes**, definida a partir dos dados já levantados pela Saúde e da capacidade operacional inicial do piloto.

5.2. Grupos prioritários e distribuição de referência

Conforme a lógica apresentada na reunião técnica, o piloto contemplará, como distribuição de referência:

Grupo	%	Nº estimado
Adultos em geral	60%	~210
Gestantes	10%	~35
Idosos	10%	~35
Adolescentes	10%	~35
Crianças	10%	~35
Total	**100%**	**~350**

Essa composição reconhece que o enfrentamento da obesidade no município demanda olhar ampliado, sem se limitar exclusivamente ao público adulto. Os critérios clínicos de acompanhamento para grupos específicos — especialmente gestantes, adolescentes e crianças — serão definidos pela equipe técnica da Secretaria de Saúde.

---

6. Unidades de Implementação

O piloto será inicialmente desenvolvido em quatro unidades estratégicas da rede, com distribuição indicativa de vagas:

Unidade	Vagas indicativas
UBS Parque São Roberto	~90
UBS Jordanésia	~90
UBS Polvilho	~85
ESF Manoel Inácio	~85
Total	**~350**

> A distribuição definitiva de vagas por unidade será validada pela Secretaria de Saúde conforme capacidade operacional, estrutura de equipe e demanda local de cada unidade.

---

7. Duração do Piloto

O programa piloto terá **duração inicial de 7 meses**, com a ressalva expressa de que o projeto não deve ser tratado como ação pontual. A intenção é que o piloto sirva como base para um programa perene, passível de institucionalização e continuidade no município, compondo a linha de cuidado municipal sobre sobrepeso e obesidade em elaboração pela Saúde.

---

8. Cronograma Operacional do Piloto

A tabela abaixo apresenta o cronograma operacional mês a mês, com os marcos principais da jornada do participante e das ações do programa.

Mês	Marco principal	Ações previstas
Mês 1	Entrada e avaliação inicial	Antropometria inicial · Consulta de enfermagem · Solicitação de exames · Inscrição e registro no programa · 1º grupo quinzenal
Mês 2	Avaliação clínica e início do cuidado	Consulta médica · Análise de exames e comorbidades · Continuidade dos grupos quinzenais · Aferição antropométrica
Mês 3	Estabilização e engajamento	Grupos quinzenais temáticos · Aferição antropométrica · Validação de créditos (faixa 1) ·

Mês	Marco principal	Ações previstas
		Reforço de adesão
Mês 4	Reavaliação intermediária (D+90)	Avaliação antropométrica e clínica · Retorno de enfermagem · Premiação/reconhecimento de ciclo 1 · Ajustes no plano individual
Mês 5	Consolidação de hábitos	Grupos quinzenais com novos temas · Aferição antropométrica · Validação de créditos (faixas 2 e 3)
Mês 6	Avaliação de metas	Reavaliação clínica e antropométrica · Consulta médica de seguimento · Reconhecimento de evolução · Ajustes finais
Mês 7	Encerramento e avaliação final	Avaliação final completa · Premiação e reconhecimento · Coleta de indicadores do piloto · Definição de continuidade

> O calendário dos grupos quinzenais e a programação temática serão elaborados pela equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde no início do piloto, respeitando a disponibilidade das equipes e as necessidades identificadas em cada unidade.

---

9. Desenho Geral do Cuidado

9.1. Entrada do participante

O fluxo inicial proposto contempla:

- antropometria inicial;
- consulta de enfermagem;
- solicitação de exames laboratoriais, quando pertinente;
- registro e inserção do participante no programa.

9.2. Jornada de acompanhamento

Ao longo do piloto, a jornada prevista inclui:

- acompanhamento antropométrico periódico;
- grupo de emagrecimento quinzenal, preferencialmente online;
- consulta médica, com previsão inicial de entrada no segundo mês;

- acompanhamento pela equipe multiprofissional;
- reavaliações periódicas.

9.3. Abordagem multiprofissional

A rede já conta com equipe multiprofissional capaz de sustentar temas recorrentes no projeto, incluindo profissionais como:

- psicologia;
- fonoaudiologia;
- fisioterapia;
- nutrição;
- enfermagem;
- medicina da estratégia da família;
- farmácia;
- odontologia, quando pertinente ao tema de mastigação e dentição.

9.4. Temas estruturantes dos grupos quinzenais

Os conteúdos e temas do programa deverão contemplar, entre outros:

- mastigação e dentição;
- leitura de rótulos;
- escolha alimentar;
- macronutrientes e seus efeitos metabólicos;
- exercício físico e seus efeitos sobre bem-estar e saúde mental;
- adesão a hábitos saudáveis;
- saúde mental e aspectos emocionais do emagrecimento;
- uso de medicamentos e adesão ao tratamento;
- compreensão de que evolução clínica e corporal não se resume exclusivamente ao peso na balança.

> A programação temática detalhada e o calendário dos encontros serão elaborados pela equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde no início do piloto.

10. Indicadores de Sucesso

10.1. Indicadores institucionais

Conforme informado pela Saúde, o piloto dialoga com indicadores já acompanhados institucionalmente:

- ações eMulti;
- diabetes;
- hipertensão arterial;
- acesso à Atenção Primária;
- cuidado com gestantes.

10.2. Indicadores específicos do piloto

Além dos indicadores institucionais, recomenda-se acompanhar:

Indicador	Meta de referência
Participantes ativos ao longo do piloto	≥ 280 (80% de permanência)
Taxa de comparecimento às avaliações	≥ 75%
Participantes com perda ≥ 5% do peso	Meta a ser validada pela Saúde
Participantes com perda ≥ 10% do peso em 6 meses	Meta piso de referência
Participantes com perda ≥ 20% do peso	Meta aspiracional
Redução média de circunferência abdominal	A ser definida como baseline no início
Parceiros mobilizados	≥ 5 ao final do piloto
Valor estrutural alavancado por apoio externo	A mensurar

> As metas específicas de perda de peso e redução de circunferência são referências aspiracionais preliminares, sujeitas à definição e validação técnica pela equipe clínica da Secretaria de Saúde, que estabelecerá os valores adequados conforme perfil dos participantes e protocolos assistenciais.

11. Estrutura Complementar e Apoio Externo

11.1. Estrutura física — Academia Funcional

O plano prevê a implantação de uma **academia funcional adaptada para pessoas com obesidade**, com estimativa inicial de referência de **R$ 150.000,00**. Esse valor poderá ser composto por:

- doação de equipamentos por parceiros;
- cessão de materiais ou espaço;
- patrocínio empresarial estrutural;
- abatimento de custos via negociação com fornecedores.

Os itens de maior custo estimado incluem esteiras adaptadas para pessoas acima do peso, bicicletas ergométricas, climatização e elementos de ambientação. O detalhamento do investimento será elaborado em etapa subsequente, em documento específico de estrutura física do piloto.

11.2. Engajamento e adesão

A estratégia de engajamento será estruturada com base em:

- gamificação do programa por créditos patrocinados (ver Minuta de Gamificação);
- apoio de empresas em premiações e incentivos;
- participação em rede de serviços e benefícios;
- eventual implantação de sistema de créditos patrocinados.

11.3. Tecnologia e monitoramento

Possibilidades complementares para o piloto:

- suporte tecnológico ao monitoramento (WhatsApp, planilhas, BI simples);
- ferramentas simples de registro de presença e evolução;
- totens com orientação educativa e aferição de circunferência abdominal em pontos estratégicos do município;
- apoio à comunicação institucional do projeto.

---

12. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Mitigação prevista
Alta taxa de evasão de participantes	Média	Estratégia de gamificação e créditos; grupos quinzenais de engajamento; contato ativo por WhatsApp
Sobrecarga das equipes de enfermagem e eMulti	Média	Distribuição entre 4 unidades; cronograma escalonado; apoio da gestão das UBS
Dificuldade de mobilizar público com obesidade grau 3	Alta	Busca ativa via SISVAN; parceria com equipes de saúde da família; comunicação acessível e sem estigma
Atraso na validação jurídica das parcerias	Média	Início imediato do processo com a Procuradoria; separar fase clínica da fase de parcerias para não bloquear o piloto

13. Governança Institucional

13.1. Papel da Secretaria Municipal de Saúde

Compete prioritariamente à Saúde:

- definir o fluxo assistencial do piloto;
- estabelecer critérios técnicos e clínicos;
- organizar o acompanhamento multiprofissional;
- definir indicadores de saúde e metas assistenciais;
- inserir o programa na linha de cuidado municipal sobre sobrepeso e obesidade.

13.2. Papel do Desenvolvimento Econômico

Nesta fase preliminar, compete prioritariamente ao DDEE:

- estruturar a proposta preliminar do projeto;
- apoiar a modelagem da gamificação e dos créditos patrocinados;
- mapear segmentos e parceiros potenciais;
- estruturar a frente externa de viabilização complementar;
- apoiar a preparação de material executivo para futuras apresentações institucionais e empresariais.

13.3. Interfaces complementares

O projeto poderá demandar articulação com:

- Secretaria de Esportes;
- Gabinete;
- Jurídico (Procuradoria);
- Comunicação;
- Secretaria de Tecnologia;
- demais áreas estratégicas da Administração, conforme maturação do piloto.

---

14. Oportunidade de Parceria com Empresas

14.1. Lógica geral

A participação empresarial, nesta proposta, é entendida como **apoio complementar**, institucionalmente orientado e sujeito à validação jurídica, sem substituição das atribuições da saúde pública municipal.

14.2. Frentes possíveis de apoio

As empresas poderão ser mobilizadas para:

- apoio estrutural à academia funcional;
- apoio tecnológico e de monitoramento;
- apoio à estratégia de engajamento e gamificação;
- apoio à rede de serviços e benefícios vinculados ao programa;
- apoio a experiências, eventos e ativações coerentes com os objetivos do projeto.

---

15. Pontos Dependentes de Validação

Os seguintes pontos dependem de aprofundamento técnico e jurídico:

- instrumento jurídico aplicável à participação privada;
- limites de exposição de marca;

- critérios de elegibilidade e integridade para apoiadores;
- estrutura de gamificação e créditos patrocinados;
- regras de uso, controle e auditoria de incentivos;
- modelo de adesão e relacionamento com a rede parceira;
- critérios clínicos específicos para grupos prioritários (gestantes, adolescentes, crianças);
- distribuição definitiva de vagas por unidade.

---

16. Próximos Passos

1. **09/04/2026** — Entrega desta proposta preliminar revisada à Secretaria de Saúde;
2. **14/04/2026** — Devolutiva e ajustes pela Secretaria de Saúde;
3. Avaliação jurídica preliminar dos formatos de apoio e incentivos (Procuradoria);
4. Consolidação da minuta de gamificação e créditos patrocinados;
5. Estruturação do mapa inicial de segmentos e parceiros;
6. **20/04/2026** — Início das apresentações do projeto a empresas e parceiros potenciais.

---

17. Considerações Finais

O Projeto **Emagrecendo Cajamar** representa uma oportunidade concreta de construção de uma resposta intersetorial, organizada e institucionalmente robusta para um desafio de saúde pública relevante no município — e chega em momento estratégico, coincidindo com a elaboração da linha de cuidado municipal sobre sobrepeso e obesidade.

Ao combinar cuidado clínico, educação em saúde, adesão, monitoramento e apoio complementar estruturado, o piloto cria as bases para uma iniciativa com potencial de permanência, replicação e fortalecimento da atuação municipal. Mais do que um programa de emagrecimento, o Emagrecendo Cajamar é o embrião de uma política pública de prevenção — mensurável, intersetorial e com vocação de continuidade independente de ciclos de gestão.